

TEMA 2.24 • DIABETES Y DISLIPIDEMIAS

Dislipidemias Genéticas

PERFIL EUNACOM 1.04.1.022

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Dislipidemias Genéticas (Hereditarias)

Cuándo Sospecharlas

La clave es el contexto: lípidos **extremadamente elevados** + antecedentes familiares + manifestaciones cutáneas o vasculares precoces.

Señales de alerta:

- LDL > 500 mg/dL o TG > 1000 mg/dL - Enfermedad cardiovascular (IAM, ACV) en familiares jóvenes o en el paciente mismo antes de los 40-45 años - **Xantomas** (depósitos de lípidos en tendones, rodillas, codos, dorso de manos) - **Xantelasmas** (manchas amarillas en párpados) - **Arco corneal** (anillo lipídico alrededor del iris antes de los 40-50 años) - Herencia **autosómica dominante** — afecta a varios miembros de la familia

Tipos Principales

TABLA 2.24.1: ENFERMEDAD VS LÍPIDO ELEVADO			
ENFERMEDAD	LÍPIDO ELEVADO	HERENCIA	CLÍNICA CARACTERÍSTICA
Hipercolesterolemia Familiar	LDL muy alto (> 300–500)	AD	Xantomas tendinosos, xantelasmas, IAM < 40 años
Hipertrigliceridemia Familiar	TG muy altos (> 1000)	AD	Pancreatitis a repetición, xantomas eruptivos
Hiperlipidemia Familiar Combinada	LDL + TG altos	AD	Fenotipo mixto, alto riesgo CV

Diagnóstico

- **Perfil lipídico** → documentar la severidad
- **Test genético** → identificar la mutación específica (gen LDLR, APOB, PCSK9 en HF; LPL en hipertrigliceridemia familiar)
- **Estudio familiar** → perfil lipídico a todos los familiares de primer grado

Tratamiento

Requiere múltiples fármacos en combinación (la respuesta a monoterapia es insuficiente):

- **Estatina de alta potencia** (Atorvastatina 40-80 mg o Rosuvastatina 20-40 mg)
- **+ Ezetimibe** (bloqueo dual de la síntesis y absorción de LDL)
- En casos extremadamente resistentes: inhibidores de PCSK9 (Evolocumab / Alirocumab)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 35 años con LDL de 320 mg/dL, xantomas en tendón de Aquiles bilateral y padre fallecido por infarto a los 48 años. ¿Diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Dislipidemias Genéticas. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La hipercolesterolemia familiar es la dislipidemia genética más importante para el EUNACOM
- HF heterocigota: LDL 190-400, xantomas tendinosos, enfermedad coronaria prematura
- HF homocigota: LDL >500, enfermedad coronaria en la infancia
- Xantomas tendinosos en Aquiles y extensores son muy sugerentes de HF
- Xantomas palmares son patognomónicos de disbetalipoproteinemia tipo III
- La hiperlipidemia familiar combinada es la más prevalente (1-2%)
- El síndrome de quilomicronemia (TG >1000) tiene alto riesgo de pancreatitis
- HF requiere estatinas de alta intensidad + ezetimibe + posiblemente inhibidores de PCSK9

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (DISLIPIDEMIAS GENÉTICAS)

PREGUNTA 1

Paciente de 35 años con LDL de 320 mg/dL, xantomas en tendón de Aquiles bilateral y padre fallecido por infarto a los 48 años. ¿Diagnóstico más probable?

- ☐ A) Dislipidemia mixta adquirida
- ☐ B) Hipercolesterolemia familiar heterocigota
- ☐ C) Hiperlipidemia familiar combinada
- ☐ D) Disbetalipoproteinemia tipo III
- ☐ E) Hipercolesterolemia familiar homocigota

PREGUNTA 2

Paciente con colesterol total 380 mg/dL, triglicéridos 350 mg/dL y xantomas palmares amarillentos. ¿Diagnóstico más probable?

- ☐ A) Hipercolesterolemia familiar
- ☐ B) Hipertrigliceridemia familiar
- ☐ C) Disbetalipoproteinemia familiar tipo III
- ☐ D) Síndrome de quilomicronemia
- ☐ E) Hiperlipidemia familiar combinada

PREGUNTA 3

¿Cuál es la dislipidemia genética más prevalente en la población?

- ☐ A) Hipercolesterolemia familiar
- ☐ B) Hiperlipidemia familiar combinada
- ☐ C) Disbetalipoproteinemia tipo III
- ☐ D) Síndrome de quilomicronemia
- ☐ E) Hipertrigliceridemia familiar

RESUMEN: DISLIPIDEMIAS GENÉTICAS

Las dislipidemias genéticas son trastornos hereditarios del metabolismo lipídico que confieren un riesgo cardiovascular significativamente aumentado. La más importante y preguntada es la hipercolesterolemia familiar (HF), causada por mutaciones en el gen del receptor de LDL, en la apolipoproteína B-100 o en PCSK9. La forma heterocigota (1 en 250-500) cursa con LDL entre 190-400 mg/dL, xantomas tendinosos (especialmente en tendón de Aquiles y extensores de los dedos), arco corneal precoz y enfermedad coronaria prematura. La forma homocigota (1 en millón) es devastadora con LDL mayor a 500 y enfermedad coronaria en la infancia. Otras dislipidemias genéticas incluyen la hiperlipidemia familiar combinada (la más prevalente, cursa con LDL y triglicéridos elevados con fenotipo variable), la disbetalipoproteinemia familiar tipo III (xantomas palmares patognomónicos, elevación de colesterol y triglicéridos por acumulación de IDL), la hipertrigliceridemia familiar (triglicéridos 200-500) y el síndrome de quilomicronemia familiar (triglicéridos mayor a 1000 con riesgo altísimo de pancreatitis). El diagnóstico de HF se basa en criterios clínicos (Dutch Lipid Clinic Network): LDL muy elevado, historia familiar de hipercolesterolemia y enfermedad coronaria prematura, xantomas tendinosos, y puede confirmarse con estudio genético. El tratamiento requiere estatinas de alta intensidad desde el diagnóstico, frecuentemente combinadas con ezetimibe e inhibidores de PCSK9 para lograr metas.